



231026021

807 高雄市三民區興隆街40號7樓

葉興松先生

目錄 (Catalogue)

項目 (Category)	頁次 (Page)
綜合分析(Summary).....	2
診斷與建議(Diagnosis and Suggestion).....	3
診斷說明(Disease Description).....	7
日常生活指導與衛教(Patient Instructions).....	8
個人病史(Medical history).....	9
體格檢查(Physical Examination).....	10
檢驗室檢查(Blood and Laboratory Tests).....	12
10年心血管疾病風險評估(10-Year Risks of Atherosclerotic Cardiovascular Disease)	15
心肺檢查(Heart and Lung Studies).....	16
內視鏡檢查(Endoscopy).....	18
影像檢查(Image Studies).....	23
其他檢查檢驗項目(Other Exams).....	29

高雄榮總健康管理中心

Health Management Center at Kaohsiung Veterans General Hospital

地址:81362高雄市左營區大中一路386號

Address: No. 386 Ta-Chung 1st RD, Kaohsiung, Taiwan 813 R.O.C

傳真Fax:886-7-3468357 / 電話Tel:886-7-3419187

<https://org.vghks.gov.tw/pcu/>



個人資料 (Personal Information)

病歷號 20598270

Hospital No :

房間號 PCU - 021

Room No :

姓名 葉興松

Name :

檢查日期 2023-10-26

Date of Examination :

性別 男

Gender : M

出生日期 1978-05-01

Date of Birth :

年齡 45歲5個月

Age : 45 years 5 month(s)

(1) 網址 : <https://org.vghks.gov.tw/pcu/>

(2) 高雄榮總掛號系統連結↓



網路掛號



Registration



綜合分析(Summary)						
專科分類		A	B	C	D	E
1	胃腸肝膽科(Gastroenterology and Hepatology)		★			
2	新陳代謝科(Endocrinology & Metabolism)		★			
3	大腸直腸外科(Colon Rectal Surgery)		★			
4	心臟內科(Cardiology)			★		
5	胸腔內科(Chest Medicine)					★
6	泌尿外科(Genital Urology)					★
7	家庭醫學科(Family Medicine)					★
8	眼科(Ophthalmology)					★
說明	A 該科有異常或疾病，請立即進一步檢查或治療 Need further evaluation and treatment.		 網路掛號  Registration			
	B 該科有異常或疾病，請定期回診追蹤治療 Please go to the Outpatient Department for a follow-up regularly.					
	C 該科有異常或疾病，有症狀者請回診追蹤或治療 Please go to the Outpatient Department for a follow-up if symptom develops.					
	D 報告結果有輕微變化，通常不影響該系統功能 We recommend a health examination as a follow-up.					
	E 無明顯異常 Normal					



診斷與建議

胃腸肝膽科

診斷：

肝功能異常
胃食道逆流
胃發炎
十二指腸第二部黏膜下腫瘤
異位性胰腺, [切片結果]
輕度脂肪肝, 依超音波
肝水囊泡, 依超音波

建議：

- ◆避免引起胃部不適之食物及藥物，如辣椒、酒、含咖啡因飲料，非類固醇類抗炎藥及抗血小板製劑等。
- ◆如有胃痛或吐酸水時，宜接受抗酸藥物治療。
- ◆依門診醫師建議，有需要時應追蹤胃鏡檢查。
- ◆宜至胃腸肝膽科門診安排內視鏡超音波或電腦斷層進一步評估十二指腸第二部黏膜下腫瘤，及決定後續治療、追蹤方式。
- ◆請追蹤異常之檢查: 肝功能
- ◆請定期追蹤腹部超音波檢查。
- ◆宜胃腸肝膽科門診進一步追蹤與檢查。

新陳代謝科

診斷：

嚴重胰島素抗性糖尿病風險增加
低密度脂蛋白偏高
三酸甘油脂異常
25-維生素D偏低
體重過重

建議：

- ◆您的理想體重是 63至77公斤
- ◆宜減輕體重，規律運動及飲食控制。
- ◆維生素D濃度偏低，宜補充維生素D。
- ◆宜3個月後追蹤空腹血糖及糖化血色素、血脂肪分析。
- ◆宜新陳代謝科門診追蹤。



大腸直腸外科

診斷：

乙狀結腸息肉

增生性息肉, [切片結果]

建議：

- ◆宜定期追蹤大腸纖維鏡檢查。
- ◆宜大腸直腸外科門診追蹤。

心臟內科

診斷：

脈波傳導速度輕微偏高, 表示心血管疾病風險增加, 依動脈硬化檢測

建議：

- ◆平日控制好危險因子, 例如; 血壓、血糖或血脂肪等。
- ◆有症狀時, 請至心臟內科門診追蹤。

審核醫師: 薛光傑 醫師

主治醫師 薛光傑



Diagnosis & Suggestions

GI

Diagnosis:

Impairment (Abnormal) of liver function
Gastroesophageal reflux
Gastritis
Duodenal submucosal nodule
Compatible with ectopic pancreas, (biopsy report)
Mild Fatty Liver, by sono
Hepatic cyst, by sono

Suggestions:

- ◆Please avoid foods and medication that may make your stomach uncomfortable, such as chili, wine, caffeine, non-steroidal anti-inflammatory and anti-platelet agents.
- ◆Antacids treatment may be used in the presence of epigastric pain or acid regurgitation.
- ◆Panendoscopy should be rechecked as necessary.
- ◆Please go to the Division of Gastroenterology and Hepatology for an endoscopic ultrasound or CT for further evaluation and treatments in the immediate future.
- ◆Please recheck abnormal tests: liver function
- ◆Repeat abdominal sonogram regularly.
- ◆Please go to the Gastro-intestinal Outpatient Department for further follow-up and evaluation.

META

Diagnosis:

severe insulin resistance, could raise the risk of diabetes
dyslipidemia
Hypertriglyceridemia
Decreased 25-OH-vitamin D level
Over weight

Suggestions:

- ◆Your ideal body weight is from 63 to 77Kg.
- ◆More exercise and less body weight are necessary. Please avoid high carbohydrate and high fat diet.
- ◆For lower vitamin D concentration, a doctor should be consulted if vitamin D should be supplemented.
- ◆Please recheck fasting glucose and HbA1c, lipid profile 3



months later.

◆Please go to the Metabolism & Endocrine Outpatient Department for a follow-up.

CRS

Diagnosis:

Sigmoid polyp

Hyperplastic polyp, (biopsy report)

Suggestions:

◆Should be follow up colonoscopy regularly.

◆Please go to the Colon Rectal Surgery Outpatient Department for a follow-up.

CV

Diagnosis:

Pulse Wave Velocity slightly higher, cardiovascular disease risk increases, by ABI

Suggestions:

◆Risk factors such as high blood pressure, diabetes mellitus (diabetes), and hyperlipidemia (high cholesterol) should be monitored closely.

◆Please go to the Cardiovascular Outpatient Department for a follow-up if symptom develops.

Name of verifying doctor: Kuang-Chieh HSUEH



診斷說明(Disease Description)

肝水囊泡

所謂「肝水囊泡」是指出現於肝臟內具有上皮細胞且充滿了液體的囊狀構造，多為良性且好發於右葉，極少部分為寄生蟲性感染所致，或可能是先天性膽道發育時殘存遺跡所造成，而年長性變化也是原因之一。一般不會對身體造成任何傷害，有10-15%的病人會有上腹不適或悶痛感，除非囊腫太大壓迫到附近的組織，或囊腫因外力或不明原因而破裂，或囊腫內出血及感染才需要進一步處理。

胃炎

胃炎在胃鏡下可見胃黏膜泛紅或是小出血點，常見的致病原因很多，如止痛藥的使用、菸酒、壓力、刺激性食物或是嚴重的身體疾病。病人可能沒有症狀或伴隨上腹部不適，食慾不振或噁心感。藉由避免造成胃部不適的食物及減輕壓力源，胃炎的情形會獲得改善。有症狀的病人可視情形服用治酸藥物來緩解症狀。

胃食道逆流

因為胃中的胃酸逆向回流至食道，導致食道被酸侵蝕造成不適、發炎或潰瘍之情形。患者常見的症狀是「心口燒灼感」及「胃酸逆流」。有時會因胃酸逆流而導致口腔及呼吸道黏膜的傷害，產生咽喉痛、聲音沙啞的現象。有的甚至在晚上睡眠中，會因酸水湧上咽喉而被嗆醒，並出現劇烈咳嗽、呼吸困難或氣喘的情形。自我照顧方式可於睡覺時，將床頭及上半身墊高約15公分，避免巧克力、薄荷糖、辛辣或油膩食物，同時少喝咖啡、可樂及酒等飲料並戒菸。大部分的胃食道逆流性疾病可藉抑酸劑及促進胃腸蠕動藥物而獲得改善，少數嚴重的患者需接受手術治療。

脂肪肝

脂肪肝顧名思義就是肝細胞裡堆積了過多的脂肪，也就是俗稱的「肝包油」。引起脂肪肝的原因最常見的是肥胖、糖尿病、酗酒、肝炎或服用藥物。肝細胞被脂肪浸潤有時會引起輕微的發炎反應，所以有些人的肝功能會異常。脂肪肝變成肝硬化的機會約3-5%，肝炎引起的脂肪肝最後進展成肝硬化的比例則多達20%。脂肪肝的治療主要須去除病因，平時要注意少油及低糖飲食，少喝酒並多運動。



日常生活指導與衛教(Patient Instructions)

高脂血症

★定義

高脂血症是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯增加。它是造成動脈硬化症和心臟病發生的一個重要危險因子；一般高血脂症病人沒有任何明顯症候。

★處理及治療

1. 一般而言，高血脂症患者先經三至六個月「飲食療法」處理，如血脂仍高才考慮併以「藥物治療」。
2. 維持理想體重、控制油脂攝取量，少吃膽固醇含量高的食物；常選用富含纖維質的食物；儘量少喝酒，控制體重可明顯降低血液中三酸甘油酯濃度，避免攝取精製甜食，並可多攝取魚類。
3. 如果飲食控制三~六個月後血脂仍高，則應考慮降血脂藥物治療。



個人病史(Medical history)

主訴

咳嗽, 打鼾

過去病史

甲狀腺結節/囊腫, 脂肪肝, 膽息肉, 韌帶損傷

手術史

骨關節系統手術

過敏史

有



體格檢查(Physical Examination)

身高(Height): 179.9 公分(cm)
 體重(Weight): 86.1 公斤(kg.)
 身體質量指數(BMI): 26.6 公斤/平方公尺(kg/m²)
 體脂比率(Body Fat Ratio): **31.1** %(
 腹圍(皮尺測量)(Abdominal girth): **98** 公分(cm)
 腰臀比(Waist-to-hip ratio): 1.02
 體溫(Temperature): 36.5 度(攝氏)(°C)
 脈搏(Pulse Rate): 77 跳/分(/min.)
 呼吸(Respiration Rate): 18 次/分(/min.)
 血壓(Blood Pressure)
 左手血壓(Blood pressure Left): 119/66 毫米汞柱(mmHg)
 其他(Others): 毫米汞柱(mmHg)
 聽力(音叉)(Ear): 無明顯異常
 皮膚(Skin): 無明顯異常
 頭眼耳鼻喉(ENT): 無明顯異常
 頸部(Neck): 無明顯異常
 甲狀腺(Thyroid gland): 無明顯異常

胸肺 (Chest & Lung)
 變形(Deformity): 無
 乳房(Breast): 無明顯異常
 腋下(Axillary): 無明顯異常
 肺部(Lungs): 清澈
 心臟 (Heart)
 心律(Rhythm): 規則
 心雜音(Murmur): 無
 腹部 (Abdomen)
 外觀(Shape): 平坦
 壓痛處(Tenderness): 無
 肝臟(Liver): 無明顯異常
 脾臟(Spleen): 無明顯異常
 肛門指診(Rectal digital Examination): 自請免檢
 四肢(Extremities): 無明顯異常
 神經系統檢查(Neurological Examination): 無明顯異常
 其他異常發現(Others): 無

視力檢查

視力(Vision): 戴眼鏡
 右眼(O.D.): 1.2
 左眼(O.S.): 1.0
 其他(Others):
 眼壓(I.O.P.):
 右眼(O.D.): 11毫米汞柱(mmHg)
 左眼(O.S.): 11毫米汞柱(mmHg)
 辨色力(Color sense): 無明顯異常

[註]理想體重範圍公式: 男性:[(身高-80)*0.7]±10%; 女性:[(身高-70)*0.6]±10%;



ID/姓名: 20598270 / 葉興松

身高: 179.9 cm 年齡: 45 歲 性別: 男性 測量日期/時間: 2023/10/26 09:54

身體組成分析

	數值	身體水份	軟組織量	除脂量	體重
身體水份 (L)	43.5 (38.6 ~ 47.1)	43.5	55.2 (49.2 ~ 60.2)	59.3 (52.8 ~ 64.6)	86.1 (60.5 ~ 81.9)
蛋白質 (kg)	11.7 (10.6 ~ 13.0)				
礦物質 (kg)	4.1 (3.7 ~ 4.5)				
體脂肪 (kg)	26.8 (10.0 ~ 15.0)				

肌肉/脂肪分析

	標準以下	標準	標準以上
體重 [kg]	50 70 90 100 115 140 160 180 200 220 240 260 [%]		86.1
骨骼肌肉重 [kg]	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		33.1
脂肪重 [kg]	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 [%]		26.8

肥胖分析

	標準以下	標準	標準以上
BMI (kg/m ²)	10.0 15.0 18.5 22.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 [%]		26.6
體脂肪百分比 [%]	5.0 10.0 15.0 17.5 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 [%]		31.1

腹部肥胖分析

	標準以下	標準	標準以上
腰臀比	0.75 0.90 1.02		
內臟脂肪程度	0 4 8 10 12		12
內臟脂肪面積 (cm ²)	50 100 175		
內臟脂肪重量 [kg]	4.4 kg 皮下脂肪重量 22.4 kg		

區段性瘦肉分析

	低	標準	高	水腫指數
右手肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		3.33	0.377
右手肌肉量百分比	82%			
左手肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		3.26	0.376
左手肌肉量百分比	81%			
軀幹肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		26.14	0.371
軀幹肌肉量百分比	86%			
右腿肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		9.05	0.374
右腿肌肉量百分比	81%			
左腿肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		9.02	0.375
左腿肌肉量百分比	81%			

身體水份分析

	標準以下	標準	標準以上
細胞內水 [L]	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		27.2
細胞外水 [L]	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]		16.3
水腫指數	0.407 0.413		0.374

綜合評估

身體類型	肥胖等級1
身體健康年齡	47 歲
基礎代謝率	1651 kcal
每日消耗總能量	2542 kcal
細胞重量	39.0 kg
身體健康評分	69 分

身體平衡評估

上半身(左/右)	☒ 平衡 ☐ 不平衡 I ☐ 不平衡 II
下半身(左/右)	☒ 平衡 ☐ 不平衡 I ☐ 不平衡 II

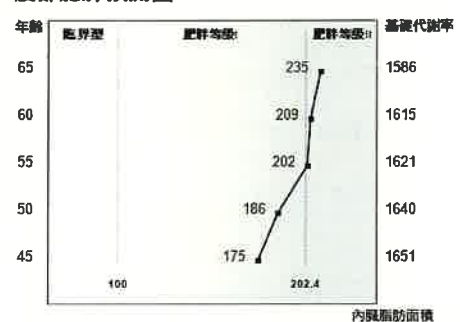
控制指南

目標體重	71.9 kg
體重控制	-14.2 kg
肌肉控制	+0.0 kg
脂肪控制	-14.2 kg

肥胖評估

BMI	☐ 體重不足 ☐ 標準 ☒ 體重過重 ☐ 肥胖
體脂肪百分比	☐ 低脂肪 ☐ 標準 ☐ 脂肪過多 ☒ 肥胖
肥胖度	+20.9 (-10.0 ~ +10.0) %
腹圍	102.5 (少於 85cm) cm

腹部肥胖預測圖



相位角: 5.5° (標準範圍: 6° ~ 8°)

阻抗係數 (613)

Freq	1K	5K	50K	250K	550K	1M
RA.Imp	354	346	308	277	266	261
LA.Imp	365	357	318	286	275	269
Trunk	30	29	25	21	20	18
RL.Imp	320	311	272	243	236	231
LL.Imp	323	315	275	246	239	233

Xc.

Freq	RA.Xc	LA.Xc	Trunk	RL.Xc	LL.Xc
50K	29	30	2	26	26

SMI: 7.61 kg/m² (標準)
(Skeletal muscle mass index)



檢驗室檢查(Blood and Laboratory Tests)

檢查項目	本次	本次參考值
檢查日期	2023/10/26	
血液學檢驗		
血紅素(Hgb.):	15.2 g/dL	M:13.4-17.2;F:11.1-15.1;
血球比容(Hematocrit):	44.9 %	M:39.8-50.7;F:34.7-45.1;
紅血球(R.B.C.):	5.15 M/uL	M:4.3-6.0;F:3.8-5.1;
平均紅血球大小(M.C.V.):	87.2 fL	V:83.4-98.5;
平均血色素(M.C.H.):	29.5 pg	V:27.4-33.3;
平均血色素濃度(MCHC):	33.9 g/dL	V:32.1-35.2;
紅血球分佈寬度(RDW):	11.7 %	V:11.5-14.5;
白血球(W.B.C.):	6.48 K/uL	V:4.1-10.5;
嗜中性球(Neutrophils):	57.9 %	V:41.8-70.8;
淋巴球(Lymphocytes):	31.0 %	V:20.7-49.2;
單核球(Monocytes):	5.9 %	V:3.6-9.2;
嗜伊紅性球(Eosinophils):	4.6 %	V:<7.6;
嗜鹼性球(Basophils):	0.6 %	V:0.2-1.5;
血小板總數(Platelet Count):	298 K/uL	V:160-370;
其他一(Other1):		
其他二(Other2):		
肝臟功能檢驗		
膽紅素總量(Total Bilirubin):	0.7 mg/dL	V:0.3-1.5;
GO轉胺基酵素(SGOT):	28 U/L	V:13-39;
GP轉胺基酵素(SGPT):	47 U/L	V:0-40;
麩胺轉酸酵素(GGT):	32 U/L	V:9-64;
全蛋白(血)(Total protein):	7.4 g/dL	V:6.4-8.9;
白蛋白(Albumin):	4.6 g/dL	V:3.5-5.7;
腎臟功能與電解質檢驗		
尿酸(Uric Acid):	6.7 mg/dL	M:4.4-7.6;F:2.3-6.6;
尿素氮(B.U.N.):	9 mg/dL	V:7-25;
肌酸酐(Creatinine):	0.85 mg/dL	M:0.7-1.3;F:0.6-1.2;



檢查項目	本次	本次參考值
檢查日期	2023/10/26	
腎絲球過濾率(eGFR):	97.5 ml/min/1.73	
血清鈣(Serum Calcium):	9.2 mg/dL	V:8.6-10.3;
血清鈉(Sodium):	137 mEq/L	V:136-146;
血清鉀(Potassium):	4.1 mEq/L	V:3.5-5.1;

新陳代謝及內分泌檢驗

空腹血糖值(Glucose):	88 mg/dL	V:70-100;
糖化血色素(Hb A1c):	5.7 %	V:4.0-6.0;
胰島素阻抗(HOMA-IR):	2.48	V:<=1;
膽固醇總量(Total Cholesterol):	199 mg/dL	V:<201;
高密度脂蛋白(HDL-C):	45 mg/dL	V:>39;
低密度脂蛋白(LDL-C):	134 mg/dL	V:<130;
總量與高密度比(T.C./HDL-C):	4.4 mg/dL	V:<5.6
三酸甘油脂(Triglyceride):	203 mg/dL	V:<151;
甲狀腺刺激素放射免疫分析(HS-TSH):	0.97 uIU/ml	V:0.25-4.0;
游離甲狀腺素放射免疫分析(Free T4):	1.16 ng/dl	V:0.7-1.8;
25-維生素D(25-OH-vitamin D):	8.1 ng/ml	V:30-100;
睪丸激素(Testosterone):	4.64 ng/mL	V:2.4-7.16; (21-49yrs):2.4-8.71 ng/mL (≥50yrs):2.21-7.16 ng/mL

腫瘤標記

阿爾法胎兒蛋白(Alpha-fetoprotein):	2.1 ng/mL	V:<10;
癌胚原抗原(CEA):	1.0 ng/mL	V:<5;
攝護腺特殊抗原(PSA):	1.13 ng/mL	V:<4;
Ca199腫瘤標記(CA-199):	3.92 U/mL	V:<35;

血清學檢查

高敏感度C反應蛋白(High-sensitivity CRP):	0.093 mg/dl	V:0.1-0.3;
----------------------------------	-------------	------------

尿液檢驗

尿生化檢查(含潛血)(URINE BIOCHEMISTRY EXAM. + O.B.):

外觀一(APPEARANCE1): 黃色



檢查項目	本次	本次參考值
檢查日期	2023/10/26	
外觀二(APPEARANCE2):	混濁	
比重(CHEM:S.P.G.):	1.020	V:1.005-1.030;
酸鹼值(PH):	7.5	V:5.0-8.0;
尿蛋白(Protein):	-	V:-;
尿糖(Sugar):	-	V:-;
酮體(KET.):	-	V:-;
尿潛血(Occult blood):	-	V:-;
尿膽素原(URO.):	正常 E.U./dL	V:Normal;
尿膽紅素(BIL.):	-	V:-;
亞硝酸鹽(NIT.):	-	V:-;
白血球酯酵素(LEU.):	-	V:-;
尿沉渣顯微鏡檢查(Urine sediments):		
紅血球(R.B.C.):	0-2 /HP	V:0-2;
白血球及膿細胞(W.B.C.):	0-2 /HP	V:0-5;
上皮細胞(Epith):	0-5 /HP	
結晶體(CRYSTAL):	AMOR. PHOSPHATE :1+ /LP	
外觀一(APPEARANCE1):	黃色	
外觀二(APPEARANCE2):	混濁	
其他(Others):	BACTERIA:1+	



10年心血管疾病風險評估(10-Year Risks of Atherosclerotic Cardiovascular Disease)

您的 10年心血管疾病風險：2.0%

一般建議

- 建議養成健康的生活習慣，例如戒菸、維持規律的運動、低鹽、低油飲食

低密度膽固醇建議(標準值根據是否有不同共病而略有不同)

- 無冠狀動脈疾病、糖尿病、周邊血管疾病、中風的病人：130mg/dL以下
- 冠狀動脈疾病的病人：70mg/dL以下
- 急性心肌梗塞合併有糖尿病的病人：55mg/dL以下
- 周邊血管疾病病患：100mg/dL以下
- 缺血性腦中風病患：100mg/dL以下
- 頸動脈狹窄合併有症狀(例如頭暈)的病患：100mg/dL以下
- 糖尿病病患：70mg/dL以下
- 40歲以下糖尿病的病人，有心血管的危險因子(男性、高血壓、抽菸)：100mg/dL以下
- 當低密度膽固醇有達到治療標準後，會建議將三酸甘油脂保持在200mg/dL以下

血壓建議(標準值根據是否有不同共病而略有不同)

- 75歲以下，沒有糖尿病、冠狀動脈疾病、腎臟疾病的族群：140/90mmHg



心肺檢查(Heart and Lung Studies)

心電圖檢查(Electrocardiogram):

正常

SINUS RHYTHM

肺功能試驗(Pulmonary Function Tests):

1. 肺活量(FVC) : 4410 毫升(091%預測值)
2. 一秒最大吐氣量(FEV1) : 3610毫升(092%預測值)
3. 一秒最大吐氣量/肺活量 : 81. %

結論:正常

HEIGHT: 179.0 cm TEMP: 23 degress of Celcius

WEIGHT: 86.0 kg PRESS: 752 mmHg

Description:

SPIROMETRY (BTPS)		PRE-RX		
		PRED	ACTUAL	%PRED
FVC	Liters	4.80	4.41	091.9
FEV1	Liters	3.90	3.61	092.6
FEV1/FVC	%		81.86	
FEF25%	L/sec	8.00	8.02	100.2
FEF50%	L/sec	5.04	5.33	105.8
FEF75%	L/sec	2.16	1.40 *	064.8
FEF200-1200	L/sec		8.93	
PEF	L/sec	9.21	9.65	104.8

COMMENT:(According to GINA 2014, GOLD 2014, ATS 1991, and
ATS/ERS consensus 2005)

The pulmonary function test shows normal ventilatory function.

動脈硬化檢測(ABI):

- 脈波傳導速度(PWV):
- 結果:輕微偏高
- 右側:1360(cm/s)
- 左側:1467(cm/s)

說明:

脈波傳導速度反應出動脈血管的彈性狀態。由上臂與腳踝脈波時間差與傳導距離，計算脈波傳導速度，當數值超過預期值越多表示動脈硬化程度愈明顯。

- 腳踝-手臂血壓比(ABI):
- 結果:



- 右腳踝-手臂血壓比:1.13, 正常
- 左腳踝-手臂血壓比:1.09, 正常

Ankle-brachial index --

Right Ankle-brachial index: 1.13

normal

Left Ankle-brachial index: 1.09

normal

Brachial-ankle Pulse Wave Velocity --

Right(cm/s): 1360

Left(cm/s): 1467

Slightly higher

Blood Pressure --

Right brachial blood pressure: 116, / 74, (mmHg)

Left brachial blood pressure: 116, / 73, (mmHg)

Right ankle blood pressure: 131, / 72, (mmHg)

Left ankle blood pressure: 127, / 77, (mmHg)



內視鏡檢查

上腸胃道內視鏡檢查

- 食道:胃食道逆流
- 胃發炎,已行尿素酵素試驗(幽門桿菌檢查)
- 十二指腸第二部黏膜下腫瘤,大小約 1.5-2 cm,已行切片併送病理組織檢驗

胃鏡病理切片報告

- 十二指腸第二部:異位性胰腺

大腸纖維鏡檢查

- 乙狀結腸息肉,大小約 0.2 cm,已行息肉切片切除併送病理組織檢驗
- 其他腸道所見範圍無明顯異常病灶
- 腸道準備程度:良好

腸鏡病理切片報告

- 乙狀結腸:增生性息肉

尿素酵素檢定(幽門桿菌檢查)

- 陰性(正常)



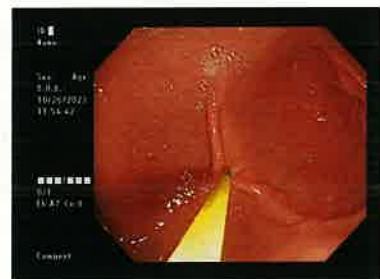
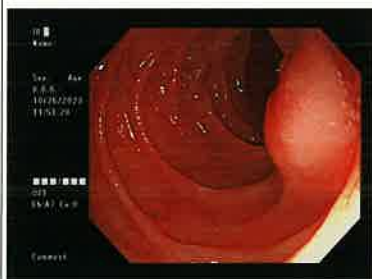
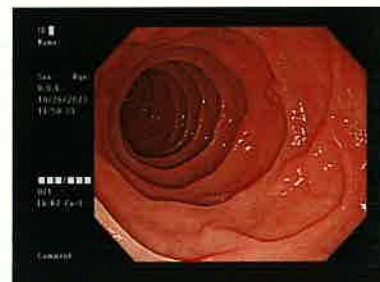
高雄榮總 健檢中心上消化道內視鏡

姓名：葉興松

年齡：45

性別：男

病歷號：20598270 序號：34150073

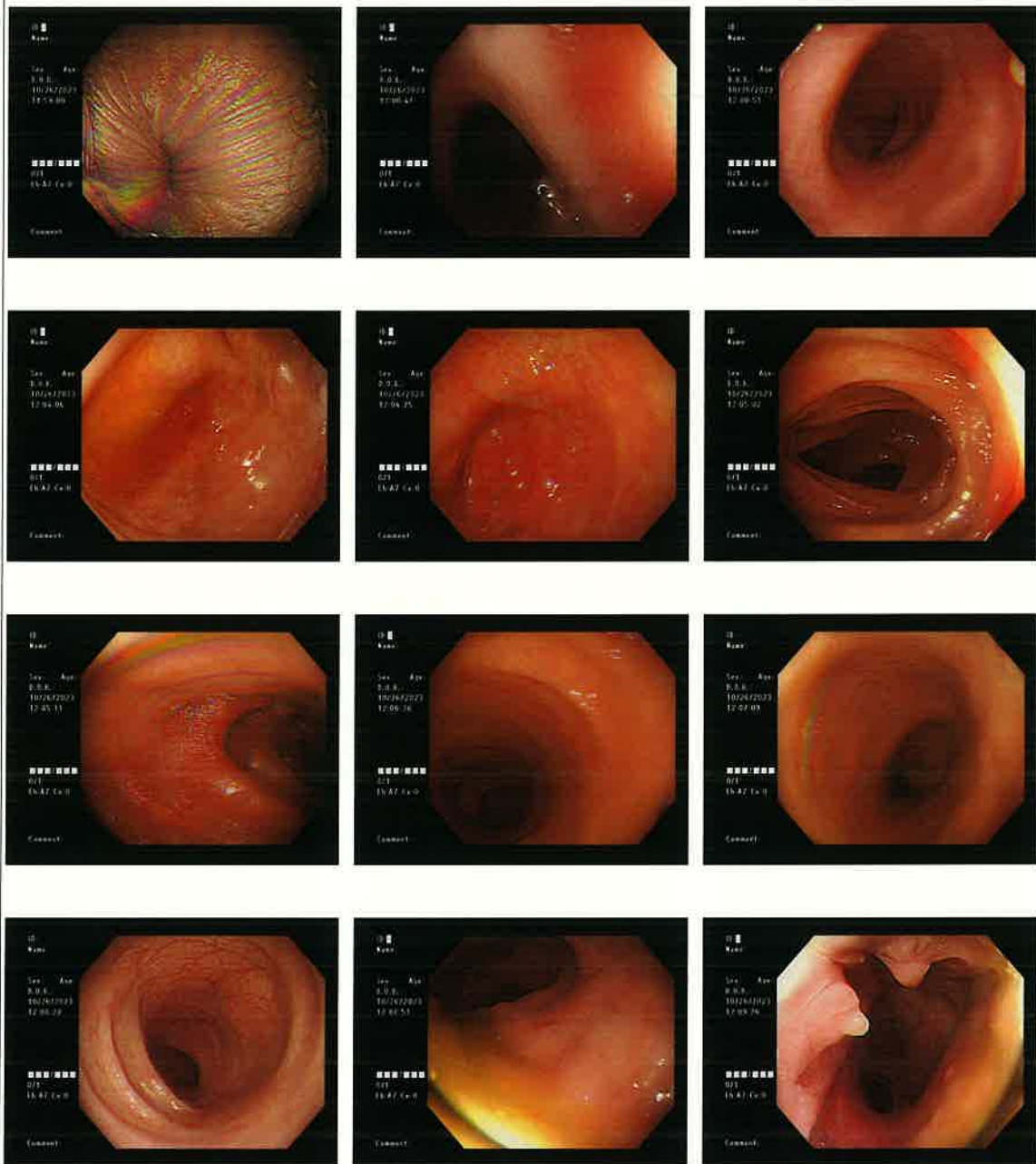




高雄榮總 健檢中心大腸鏡檢查

姓名：葉興松

年齡：45 性別：男 病歷號：20598270 序號：34150074





Endoscopy

Panendoscopy, upper GI(PCU)

The patient was sedated with intravenous 2% Fresofol 200 mg, Midatin 0 mg, Aentanyl 500 ug, and 2% Lidocain 50 mg.

Esophagus: One linear mucosal defect with length < 5 mm at EG junction was noted. Reflux esophagitis, Los Angeles grade A, was suspected.

Stomach: Some hyperemic patches over antrum were noted. Biopsy was done for rapid urease test of Helicobacter pylori.

Duodenum: Bulb looked no specific finding. One subepithelial lesion sized 1.5~2cm was noted at posterior wall of proximal second portion, biopsy was done to r/o malignancy.

Gastroesophageal flap valve, Hill' s classification grade II.

Suggestion:
pend pathological report,
consider abdominal CT or EUS survey if needed

GI Pathological Biopsy Result

Duodenum, proximal second portion, endoscopic biopsy
--- Compatible with ectopic pancreas

Colon fiberoscopy(PCU)

Information --
Scope Model : Olympus CF-Q290L
Polyp excision : Y
Video Record : N
Operation time --
Performing duration: 11, minutes

Insertion level --
Insertion level : Cecum

Premedication --
Antispasmodic drugs : Nil, course:others
Analgesic sedative drugs : Yes fresofol(Propofol)/mg, 120

Colon cleansing agent --
Colon cleansing agent: Bow Klean Powder
Preparation time : Split dose
Colon cleansing level : Excellent

Anti-platelet --
Anti-platelet : Nil
Immediate Complication --
Complication : Nil
Lesionl --
Diagl : polyp



Diagl_polyp : adenoma
Diagl_polyp_adenoma : Tubular adenoma
Location1: Sigmoid colon,
25,cm from anal verge
Treatment1 : Yes S/p biopsy and removal
Complete remove lesion1 : Yes
Specimen1 : Yes size(Endoscopy/cm): 0.2, number: 1, serial no.(
A to Z): A

Specimen --
number: 1,(include Hyperplastic polyp)

Comment --
Suggestion : Pending pathological report and/u colonoscopic
exam next year

CRS Pathological Biopsy Result

Sigmoid colon, 25 cm from anal verge, colonoscopic biopsy and removal
--- Hyperplastic polyp

Urease test

RESULT: Negative



影像檢查(Image Studies)

胸部X光檢查（正左、側面攝影）二張(Chest PA, Lat (LT)):

所見範圍無明顯異常

Health Check-Up Chest Radiograph Findings (According to age)

=====

=

Lung:

not unusual for age and no evident nodule > 1 cm

Mediastinum, Heart and Vessel

not unusual for age

Thoracic Cage and Upper Abdomen

not unusual for age



骨質密度測定(Bone densitometry):

- 骨質密度符合同年齡的預期值 (正常)
- 腰椎骨密度: 第1腰椎至第4腰椎平均為1.251g/cm²
- 右側大腿股骨近端骨密度: 股骨頸為0.833g/cm²及全股骨為0.901g/cm²
- 左側大腿股骨近端骨密度: 股骨頸為0.869g/cm²及全股骨為0.899g/cm²
- 最低Z值等於-1.5

備註:

依據2015年國際臨床骨質密度檢測學會之共識, 當Z值等於或低於-2.0時稱之為「低於同齡的預期值」, 當Z值高於-2.0時稱之為「符合同齡的預期值」。

Bone Mineral Densitometry (BMD) Report Form:

Bone Mineral Density:

Quantification of Bone Mineral Density by Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA, GE-Lunar/iDXA).

Sex: M

Age: 45.0

Findings:

The Z-scores Database is calculated by Combined NHANES/Lunar Normative Database.

The BMD at Lumbar spine: average BMD at L1-L4 is 1.251 g/cm².

The BMD at Right proximal femur: femoral neck is 0.833 g/cm² and total femur is 0.901 g/cm².

The BMD at Left proximal femur: femoral neck is 0.869 g/cm² and total femur is 0.899 g/cm².

The lowest Z-score is -1.5 .

Conclusion:

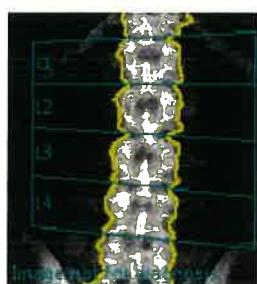
The BMD meets the criteria was within the expected range for age, according to 2015 ISCD(the International Society for Clinical Densitometry) combined official positions.



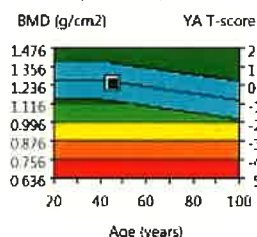
Kaohsiung Veterans General Hospital

No.386, Dazhong 1st Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 81362, Taiwan(R.O.C)

Patient:	Yeh Shing Song	Referring Physician:	3494
Birth Date:	1978/5/1	Age:	45.4 years
Height:	179.9 cm	Weight:	86.1 kg
Sex:	Male	Ethnicity:	Asian
		Patient ID:	20598270
		Exam Date:	2023/10/26 上午 11:14:10
		Menopause Age:	
		Attendant:	G237



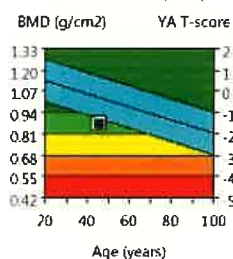
USA (Combined NHANES/Lunar) AP Spine: L1-L4 (BMD)



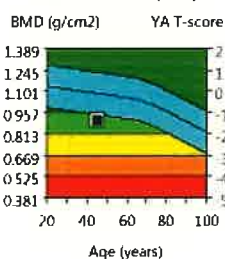
Region	BMD (g/cm ²)	Y.A. T-score	A.M. Z-score
L1	1.204	0.3	0.1
L2	1.247	0.0	-0.2
L3	1.247	-0.1	-0.3
L4	1.297	0.3	0.1
L1-L2	1.227	0.1	0.0
L1-L3	1.234	0.1	-0.1
L1-L4	1.251	0.1	0.0
L2-L3	1.247	-0.1	-0.2
L2-L4	1.265	0.1	-0.1
L3-L4	1.273	0.1	-0.1



USA (Combined NHANES/Lunar) Left Femur: Neck (BMD)



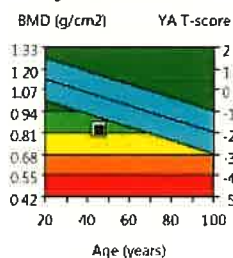
USA (Combined NHANES/Lunar) Left Femur: Total (BMD)



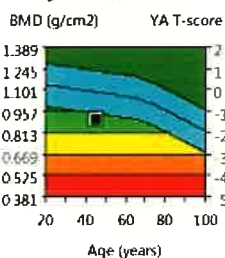
Region	BMD (g/cm ²)	Y.A. T-score	A.M. Z-score
Neck Left	0.869	-1.5	-1.3
Total Left	0.899	-1.4	-1.3



USA (Combined NHANES/Lunar) Right Femur: Neck (BMD)



USA (Combined NHANES/Lunar) Right Femur: Total (BMD)



Region	BMD (g/cm ²)	Y.A. T-score	A.M. Z-score
Neck Right	0.833	-1.8	-1.5
Total Right	0.901	-1.4	-1.3

Statistically 68% of repeats scans fall within 1SD (i.e. 0.008 g/cm² for AP Spine L1-L4; 1.00 L2 g/cm² for Left Femur Neck); USA (Combined NHANES (ages 20-30) / Lunar (ages 20-40)) AP Spine Reference Population (M13); USA (Combined NHANES (ages 20-30) / Lunar (ages 20-40)) Femur Reference Population (M13); AP Spine Matched for Age, Weight (males 25-100 kg), Ethnic; Left Femur Matched for Age, Weight (males 25-100 kg), Ethnic; World Health Organization - Definition of Osteoporosis and Low Bone Mass for Caucasian Women; Normal = T-score at or above -1.0 SD; Low Bone Mass = T-score between -1.0 and -2.5 SD; Osteoporosis = T-score at or below -2.5 SD; (WHO definitions only apply when a young healthy Caucasian Women reference database is used to determine T-scores.)
Date created: 2023/10/26 11:29:32.15 JSP I; Filename: yw84364#Lmax; AP Spine: 100:2.50:50.00:60.00:10.68 0.30x0.2523.7%; Fat=40.7%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Scan Mode: Standard; OneScan: 146.0 uGy; Left Femur: 100:2.50:50.00:60.00:12.06 0.30x0.25 19.0%; Fat=23.0%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Neck Angle (deg)= 45; Scan Mode: Standard; 146.0 uGy; Right Femur: 100:2.50:50.00:60.00:11.64 0.30x0.25 18.3%; Fat=23.4%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Neck Angle (deg)= 47; Scan Mode: Standard; 146.0 uGy



腹部攝影（仰臥）（KUB, Supine）:

所見範圍無明顯異常

KUB for PCU

Non-specific bowel gas pattern

No radio-opaque stone density.

The bony structure is not unusual for age



上腹部超音波檢查 (Sono, Upper abdomen):

- 輕度脂肪肝
- 肝水囊泡, 大小約 1.87 cm
- 膽囊、膽道、腎臟、脾臟、胰臟頭部及體部所見範圍無明顯異常病灶
- 胰臟尾部腸氣遮蔽

Report form for sonogram of upper abdomen

Clinical history:
for PCU

Major Study Conclusion(s) deserving immediate attention
no major abnormalities detected.

Minor Imaging Conclusion:

- 1) suggesting fatty liver disease, mild degree
- 2) liver cysts

Essentially negative results of

- 1) Gallbladder
- 2) Bile ducts
- 3) visible pancreas
- 4) Kidneys
- 5) Spleen

Imaging findings:

Liver:

some abnormalities stated as follows

echogenicity: hyperechoic, mild degree

*Some anechoic hepatic cysts, the largest one about 1.87 (cm in size.)

Gallbladder:

normal

Bile ducts

intrahepatic and extrahepatic bile ducts not dilated

Pancreas:

head, body appeared normal ; tail obscured by bowel gas

Kidneys

essential negative findings

Spleen:

normal



下腹部超音波檢查(Sono, Lower abdomen):

- 膀胱無明顯異常病灶
- 攝護腺容積約 21.46 ml

Report form for sonogram of lower abdomen

Normal appearance of the urinary bladder.

Data Populated from UltraSound measurements:

Accession No:34150078

SR auto-population

Prostate volume is assessed and measured, height (3.25) cm * width (3.52) cm * length (3.59) cm, volume about (21.46) ml.



其他檢查檢驗項目

其他檢查(Others):

無

Nil

